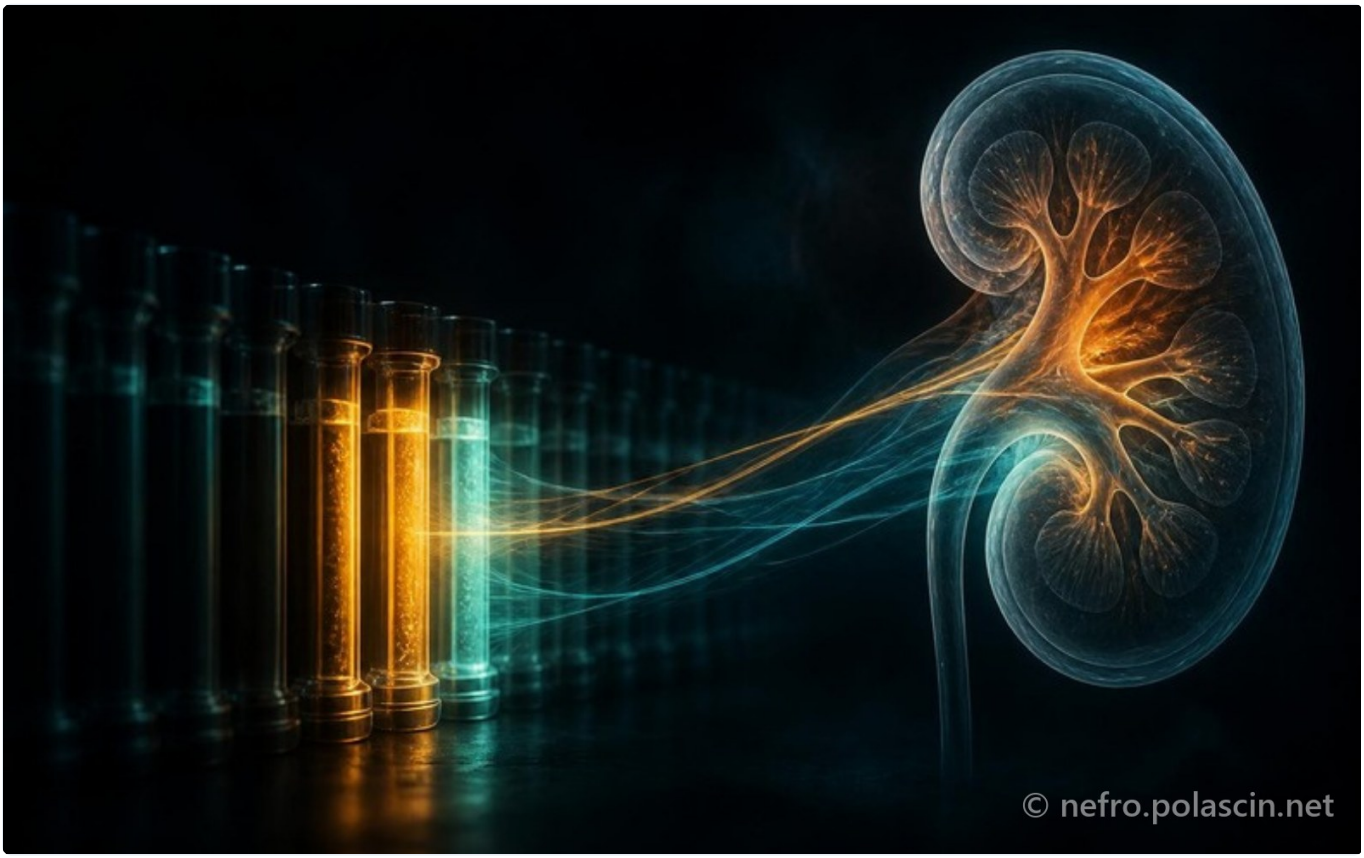
Klug entscheiden v nefrológii: ktoré laboratórne vyšetrenia sú naozaj potrebné?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Viac vyšetrení neznamená lepšie rozhodnutie – hodnotu má len to, čo skutočne mení postup.

Iniciatíva **„Klug entscheiden“** (v preklade „rozumne sa rozhodovať“) – vedená spoločnosťou DGIM (Nemecká spoločnosť pre vnútorné lekárstvo) spolu s odbornými spoločnosťami – sa snaží obmedziť zbytočný „laboratórny skríning“ bez jasného klinického dôvodu a zároveň zabrániť tomu, aby sa prehliadli vyšetrenia, ktoré reálne menia manažment pacienta. V nefrológii ide predovšetkým o skoré zachytenie ochorenia a stratifikáciu rizika pri CKD pomocou jednoduchých krvných a močových testov a vybraných parametrov minerálovo-kostného metabolizmu.

1) Pre koho to platí (praktický rámec)

Odporúčania sa viažu najmä na **rizikových pacientov** a na **CKD (chronická choroba obličiek) od určitej úrovne eGFR**, kde má laboratórium priamy vplyv na:

- pravdepodobnosť orgánového poškodenia,
- kardiorenálne riziko,
- plán ďalšej diagnostiky alebo nefrologickej konzultácie.

2) Laboratóriá, ktoré „majú zmysel“: pozitívne odporúčania (P1 až P5)

P1. Skoré zachytenie: kreatinín + močový status v sledovaní rizikových pacientov

Pri **priebežných kontrolách** u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym a renálnym rizikom sa odporúča, aby súčasťou boli:

- **stanovenie kreatinínu** (z neho sa počíta eGFR),
- **močový status** (orientačný záchyt abnormalít v moči).

Intervaly sledovania závisia od rizikovej skupiny; dokument pri rizikových skupinách uvádza kontrolu raz za 1 – 2 roky.

P2. Stratifikácia rizika pri CKD: eGFR + kvantifikácia proteinúrie/albuminúrie

Ak ide o **CKD s eGFR < 60 ml/min/1,73 m²**, odporúča sa popri eGFR aj:

- **kvantitatívne stanovenie proteinúrie/albuminúrie**, napríklad ako **albumín-kreatinínový pomer (ACR)** v spontánnom alebo zbernom moči.

Samotná eGFR riziko nemusí dostatočne vystihnúť. **Rozsah albuminúrie/proteinúrie** významne dopĺňa prognostiku (kardiorenálne výsledky aj priebeh ochorenia).

P3. Minerálovo-kostný metabolizmus pri pokročilejšej CKD: Ca, P, iPTH, 25-OH vitamín D

Pri **CKD a eGFR < 45 ml/min/1,73 m²** sa odporúča aspoň raz doplniť a pri patologických nálezoch následne sledovať:

- **sérové kalcium (Ca)**,
- **sérový fosfor (P)**,
- **intaktný PTH (iPTH)**,
- **25-OH vitamín D3**.

Cieľom je zachytiť poruchy v rámci CKD-MBD (minerálová a kostná porucha pri CKD) včas, keď sa ešte dá cielene ovplyvniť ďalší vývoj a znížiť riziká spojené s kostným a kardiovaskulárnym poškodením.

P4. Laboratórium ako súčasť rozhodovania o kontraste: racionálne zvažovanie rizika

Toto odporúčanie sa netýka len laboratória. Podstatou je, že pri **vyššom stupni poruchy funkcie obličiek (CKD 4 – 5; eGFR < 30 ml/min/1,73 m²)** treba zvážiť diagnostický prínos kontrastného vyšetrenia oproti potenciálnym rizikám tak, aby nevznikalo **systematické poddiagnostikovanie**.

eGFR tu slúži ako jeden zo vstupov do rozhodnutia, nie ako „automatický reflex“ pred každým vyšetrením.

P5. Prevencia infekcií cez pravidelnú kontrolu očkovania

Aj tu ide skôr o organizačnú a preventívnu rovinu: pri CKD a/alebo imunosupresii sa má pravidelne kontrolovať očkovací status. Nejde o laboratórne hodnoty, no rieši sa to často v rámci tej istej nefrologickej starostlivosti.

3) Čomu sa vyhnúť (negatívne odporúčania) a čo to znamená pre „zmysluplné laboratórium“

Dokument obsahuje aj negatívne odporúčania. Nehovoria, aké vyšetrenia robiť, ale ukazujú logiku iniciatívy:

- **Nevytvárať zbytočný režim zvýšeného príjmu tekutín len preto, aby sa „zlepšila funkcia obličiek“** (žiadna automatická vysoká perorálna hydratácia na „prepláchnutie“).
- **Neplytvať klinickým časom ani nezaťažovať obličky diuretikami a tekutinami s cieľom „zabrzdiť“ alebo „zvrátiť“ akútne poškodenie**, ak na to nie je jasná indikácia.
- **Lieky používať „šetriaco“** – napríklad sa neodporúča pravidelné podávanie NSAID (nesteroidové antiflogistiká) u pacientov s hypertenziou alebo CKD.

Pre laboratórnu prax z toho vyplýva rovnaký princíp: tak ako liečba, ani laboratórne vyšetrenia sa nemajú robiť plošne, ak sa od nich nečaká vplyv na rozhodnutie.

4) Praktické zhrnutie pre ambulanciu nefrológa

Úsporný nefrologický laboratórny balík v duchu Klug entscheiden stojí na týchto základoch:

- **kreatinín → eGFR** + **močový status** pri sledovaní rizikových pacientov,
- pri **CKD < 60**: **eGFR + kvantifikácia ACR/proteinúrie**,
- pri **CKD < 45**: **Ca, fosfor, iPTH, 25-OH vitamín D3**.

Zvyšok má byť naviazaný na symptómy, riziko a konkrétnu klinickú otázku.

Zdroj: *Klug-entscheiden-Empfehlungen in der Nephrologie (DGIM, s podporou DGfN), Internist 2017; publikované aj ako PDF odporúčaní. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=klug-entscheiden-nefrologia-laboratorne-vysetrenia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.